FOSEMRED

Fosaprepitant 150 mg polvo para reconstituir solución para infusión

COMPOSICIÓN

Cada vial contiene:

Fosaprepitant Dimeglumina equivalente a

Fosaprepitant 150 mg

(Liofilizado)

Excipientes: Lactosa anhidra, Edetato disódico anhidro, Polisorbato 80, Hidróxido de sodio y ácido clorhídrico para ajustar el pH.

INFORMACIÓN CLÍNICA

Indicaciones

En combinación con otros agentes antieméticos está indicado para prevención de la náusea y el vómito agudos y tardíos asociados con el tratamiento inicial y recurrente de:

• quimioterapia anticancerosa altamente emetogénica.

• quimioterapia anticancerosa moderadamente emetogénica.

Posología y método de administración

La dosis recomendada es 150 mg administrada como una infusión **durante 20-30 minutos** el Día 1, iniciada aproximadamente 30 minutos antes de la quimioterapia. Fosaprepitant se debe administrar conjuntamente con un corticosteroide y un antagonista 5-HT_3 según lo especificado en las tablas que se muestran a continuación.

Se recomiendan los siguientes regímenes para prevenir las náuseas y vómito asociados a la quimioterapia emetogénica para el cáncer.

Régimen de quimioterapia altamente emetogénico

	Día 1	Día 2	Día 3	Día 4
Fosaprepitant	150 mg vía intravenosa	ninguno	ninguno	ninguno
Dexametasona	12 mg vía oral	8 mg vía oral	**8 mg vía oral dos veces al día**	**8 mg vía oral dos veces al día**

Antagonistas 5-HT_3	Dosis estándar de antagonistas 5-HT_3. Véase información sobre la dosificación apropiada en la información del producto seleccionado antagonista 5-HT_3	ninguno	ninguno	ninguno

Se debe administrar **dexametasona** 30 minutos antes del tratamiento de quimioterapia el Día 1 y en la mañana los Días 2 a 4. También se debe administrar dexametasona en la noche de los Días 3 y 4. A la dosis de dexametasona se atribuyen las interacciones de la sustancia activa.

Régimen de quimioterapia moderadamente emetogénico

	Día 1
Fosaprepitant	150 mg vía intravenosa
Dexametasona	12 mg vía oral
Antagonistas 5-HT_3	Dosis estándar de antagonistas 5-HT_3. Véase información sobre la dosificación apropiada en la información del producto seleccionado antagonista 5-HT_3

Dexametasona se debe administrar 30 minutos antes del tratamiento de quimioterapia el Día 1. A la dosis de dexametasona se atribuyen las interacciones de la sustancia activa.

Los datos de eficacia en combinación con otros corticosteroides y antagonistas 5-HT_3 son limitados. Véase en la sección de **Interacción con otros productos medicinales y otras formas de interacción,** información adicional sobre la coadministración con corticosteroides.

Consulte en la Información de prescripción los productos medicinales antagonistas 5-HT_3 coadministrados.

Poblaciones especiales

Ancianos (≥65 años)

No se requiere ajuste de la dosis para los ancianos.

Sexo

No se requiere ajuste de la dosis según el sexo.

Daño renal

No se requiere ajuste de la dosis para pacientes con daño renal o para pacientes con enfermedad renal terminal sometidos a hemodiálisis.

Daño hepático

No se requiere ajuste de la dosis para pacientes con daño hepático leve. Los datos sobre pacientes con daño hepático moderado son limitados y no existen datos en pacientes con daño hepático severo. Fosaprepitant se debe usar con precaución en estos pacientes.

Población pediátrica

Todavía no se ha establecido la seguridad y eficacia de fosaprepitant en niños y adolescentes menores de 18 años de edad.

Método de administración

Fosaprepitant 150 mg se debe administrar por vía intravenosa y no se debe administrar por vía intramuscular o subcutánea. La administración intravenosa se lleva a cabo preferiblemente a través de una infusión intravenosa continua durante 20-30 minutos. No se debe administrar fosaprepitant como una inyección en bolo o en solución no diluida.

Instrucciones sobre la reconstitución y dilución del producto medicinal previamente a la administración

Fosaprepitant se debe reconstituir y diluir antes de la administración.

Preparación de fosaprepitant 150 mg para administración intravenosa:

1. Inyecte dentro del vial 5 ml de solución de cloruro de sodio 9 mg/ml (0.9 %) para inyección. Asegúrese de que la solución de cloruro de sodio 9 mg/ml (0.9 %) para inyección se añada al vial a lo largo de la pared de este, con el fin de prevenir la formación de espuma. Gire suavemente el vial. Evite agitarlo y empujar a presión dentro del vial la solución de cloruro de sodio 9 mg/ml (0.9 %) para inyección.

2. Prepare una bolsa de infusión llenándola con 145 ml de solución de cloruro de sodio 9 mg/ml (0.9 %) para inyección (por ejemplo, retirando 105 ml de solución de cloruro de sodio 9 mg/ml (0.9 %) para inyección de una bolsa para infusión de 250 ml de solución de cloruro de sodio 9 mg/ml (0.9 %)).

3. Retire la totalidad de volumen del vial y transfiéralo a una bolsa para infusión que contenga 145 ml de solución de cloruro de sodio 9 mg/ml (0.9 %) para inyección para completar un volumen total de 150 ml. Invierta suavemente la bolsa 2-3 veces.

El producto medicinal no se debe reconstituir ni mezclar con soluciones para las cuales no se haya establecido compatibilidad física y química.

El aspecto de la solución reconstituida es el mismo del diluyente.

El producto medicinal reconstituido y diluido debe ser inspeccionado visualmente para detectar material en partículas y decoloración antes de la administración.

No hay requerimientos especiales para su desecho.

Contraindicaciones:

- Está contraindicado en los pacientes con hipersensibilidad a Fosaprepitant IV, aprepitant, polisorbato o a cualquier otro de los componentes del producto.
- No debe emplearse concomitante con pimocida, terfenadina, astemizol o cisaprida.

La inhibición de la isoenzima 3a4 del citocromo P450 (CYP3A4) por el aprepitant podría originar concentraciones plasmáticas elevadas de estos medicamentos, causando potencialmente reacciones serias o que amenacen la vida.

Advertencias especiales y precauciones especiales de uso

Debido a que fosaprepitant es rápidamente convertido a aprepitant (un inhibidor débil a moderado de CYP3A4), fosaprepitant debe ser usado con precaución en pacientes que están recibiendo de manera concomitante medicamentos administrados por vía oral que son primariamente metabolizados a través de CYP3A4; algunos agentes quimioterapéuticos son metabolizados por CYP3A4 . La inhibición débil de CYP3A4 por fosaprepitant 150mg podría resultar en concentraciones plasmáticas elevadas de estos medicamentos concomitantes de administración oral.

Reacciones de hipersensibilidad inmediata incluyendo enrojecimiento, eritema, disnea y shock anafilaxis/anafiláctico han ocurrido durante o inmediatamente después de la infusión de fosaprepitant. Estas reacciones de hipersensibilidad han respondido generalmente a la descontinuación de la infusión y la administración de la terapia apropiada. No es recomendable reiniciar la infusión en pacientes que han experimentado reacciones de hipersensibilidad.

La coadministración de fosaprepitant con warfarina podría generar una disminución clínicamente significativa del tiempo de protrombina, reportado como la Razón Normalizada Internacional (RNI). En los pacientes bajo tratamiento crónico con warfarina, se debe vigilar estrechamente el RNI en el período de 2 semanas, particularmente en los Días 7 al 10, después de iniciado el régimen de fosaprepitant en cada ciclo de quimioterapia.

La eficacia de los anticonceptivos hormonales puede disminuir durante y hasta por 28 días después de la administración de fosaprepitant. Se deben utilizar métodos anticonceptivos alternativos o de reemplazo durante el tratamiento con fosaprepitant por 1 mes después de la última dosis.

Otras advertencias y precauciones:

<u>Pacientes con daño hepático moderado a severo</u>

Los datos en pacientes con daño hepático moderado son limitados y no existen datos en pacientes con daño hepático severo. Fosaprepitant se debe usar con precaución en estos pacientes.

<u>Reacciones a la administración y sitio de infusión</u>

Fosaprepitant no se debe administrar como inyección en bolo; siempre se debe diluir y administrar como infusión intravenosa lenta. Fosaprepitant no se debe administrar por vía intramuscular o subcutánea. Se ha observado trombosis leve en el sitio de inyección a dosis más altas. Si ocurren signos o síntomas de irritación local, se debe finalizar la inyección o infusión y reiniciarla en otra vena.

Interacción con otros productos medicinales y otras formas de interacción

Interacciones farmacológicas

Cuando se administra de forma intravenosa, el fosaprepitant es rápidamente convertido a aprepitant. Por lo tanto, las interacciones farmacológicas posteriores a la administración de fosaprepitant es probable que ocurran con fármacos que interactúen con aprepitant oral. La siguiente información se obtuvo de estudios realizados con aprepitant oral y estudios realizados con fosaprepitant coadministrado con dexametasona, midazolam o diltiazem.

El aprepitant es sustrato, inhibidor débil a moderado e inductor de la CYP3A4. También es inductor de la CYP2C9.

Fosaprepitant IV 150mg, dado en dosis individuales, es inhibidor débil de la CYP3A4, y no induce la CYP3A4. Se ha previsto que Fosaprepitant IV 150mg podría causar menos o no más inducción de la CYP2C9 que la causada por la administración de aprepitant oral.

Efecto del fosaprepitant/ aprepitant sobre la farmacocinética de otros medicamentos
El aprepitant como inhibidor débil a moderado de la CYP3A4 y Fosaprepitant IV 150mg como inhibidor débil, pueden aumentar las concentraciones plasmáticas de medicamentos coadministrados que sean metabolizados por la CYP3A4.

Fosaprepitant no se debe emplear al mismo tiempo que pimozida, terfenadina, astemizol o cisaprida. La inhibición de la CYP3A4 por el aprepitant puede resultar en concentraciones plasmáticas elevadas de estos medicamentos, causando potencialmente reacciones serias o que amenacen la vida.

Se recomienda tener precaución durante la administración concomitante de fosaprepitant y sustancias activas que sean metabolizadas principalmente a través del CYP3A4 y que tengan un rango terapéutico estrecho, tales como ciclosporina, tacrolimus, sirolimus, everolimus, alfentanil, diergotamina, ergotamina, fentanil, y quinidina.

El aprepitant ha mostrado inducir el metabolismo de la S(-) warfarina y tolbutamida, que son metabolizadas por la enzima CYP2C9. La coadministración de fosaprepitant con estos u otros medicamentos que se conozcan sean metabolizados por la CYP2C9, como la fenitoína, puede resultar en concentraciones plasmáticas disminuidas de estos medicamentos.

No es usual que fosaprepitant interactúe con medicamentos que sean sustratos para el transportador de la P-glucoproteína, como lo demostró la ausencia de interacción entre aprepitant oral con la digoxina en un estudio clínico sobre interacciones farmacológicas.

Antagonistas de la 5-HT3: En estudios clínicos sobre interacciones farmacológicas, el aprepitant cuando es administrado con régimen de 125mg en el día 1 y 80 mg en los días 2 y 3; no tuvo

efectos de importancia clínica sobre la farmacocinética del ondansetrón, granisetrón, o hidrodolasetrón (el metabolito activo del dolasetrón).

Corticosteroides:

Dexametasona: Cuando se administra fosaprepitant 150mg en una dosis única intravenosa en el Día 1, aumenta el área bajo la curva ABC0-24hr de la dexametasona, un sustrato de la CYP3A4, aproximadamente dos veces en los Días 1 y 2 cuando la dexametasona es coadministrada en dosis oral individual de 8mg en los Días 1, 2 y 3. La dosis oral de dexametasona en los Días 1 y 2 debe ser reducida aproximadamente 50% cuando se coadministra con fosaprepitant 150mg IV en el Día 1, para obtener concentraciones de dexametasona similares a las obtenidas cuando se administra sin fosaprepitant 150mg.

Metilprednisolona: Cuando se coadministraron 125 mg de aprepitant por vía oral en el Día 1 y 80 mg/día en los Días 2 y 3, aumentó el área bajo la curva de metilprednisolona, sustrato de la CYP3A4, 1.3 veces en el Día 1 y 2.5 veces en el Día 3, cuando se administró de manera concomitante con 125mg de metilprednisolona por vía intravenosa el Día 1 y 40mg por vía oral los Días 2 y 3.

Medicamentos quimioterapéuticos:

En los estudios clínicos se coadministró aprepitant oral con los siguientes medicamentos quimioterapéuticos metabolizados primariamente o parcialmente por la CYP3A4: Etopóxido, Vinorelbina, Docetaxel, ifosfamida, ciclofosfamida, irinotecan y Paclitaxel. Las dosis de estos medicamentos no se ajustaron para avalar las interacciones farmacológicas potenciales. Se recomienda precaución y un cuidadoso monitoreo en pacientes que estén recibiendo estos medicamentos u otros medicamentos quimioterapéuticos metabolizados principalmente por el CYP3A4. Se han reportado eventos postmercadeo de neurotoxicidad, una reacción adversa potencial de ifosfamida, tras la administración concomitante de aprepitant e ifosfamida.

Docetaxel: En un estudio farmacocinético separado, aprepitant oral (régimen CINV (prevención de náuseas y vomito inducida por quimioterapia)) no influenció la farmacocinética de docetaxel.

Vinorelbina: En un estudio farmacocinético separado, aprepitant oral (régimen CINV) no influenció la farmacocinética de vinorelbina.

Warfarina: Se administró una sola dosis de 125 mg de aprepitant oral el Día 1 y 80 mg por día los Días 2 y 3 en sujetos sanos estabilizados bajo tratamiento crónico con warfarina. Aunque aprepitant oral no tuvo ningún efecto sobre el ABC de la warfarina R(+) o S(-) calculada el Día 3, cinco días después de terminar la administración de aprepitant oral disminuyó 34% la concentración mínima de warfarina S(-) (un sustrato de CYP2C9) y 14% el tiempo de protrombina (reportado como la Razón Normalizada Internacional, RNI). En los pacientes bajo tratamiento crónico con warfarina, el tiempo de protombina (RNI) debe ser vigilado estrechamente en el

período de 2 semanas, particularmente en los Días 7 al 10 después de iniciar el régimen de fosaprepitant con cada ciclo de quimioterapia.

Tolbutamida: Aprepitant oral, cuando se administró en una dosis de 125 mg el Día 1 y 80 mg/día los Días 2 y 3, disminuyó el ABC de tolbutamida (un sustrato de la CYP2C9) en 23% en el Día 4, 28% en el Día 8 y 15% en el Día 15, cuando fue administrada una sola dosis oral de tolbutamida 500mg antes de administrar el esquema de 3 días de aprepitant oral y en los Días 4, 8 y 15.

Anticonceptivos orales: La administración de una cápsula de 100 mg de aprepitant una vez al día durante 14 días junto con un anticonceptivo oral con 35 mcg de etinilestradiol y 1 mg de noretindrona disminuyó 43% el ABC de etinilestradiol y 8% el de noretindrona.

En otro estudio, una dosis única por vía oral de otro anticonceptivo que contiene etinilestradiol y noretindrona se administró del Día 1 al 21 con aprepitant oral, dado en un régimen de 125 mg el Día 8 y 80 mg/día los Días 9 y 10 con ondansetrón 32 mg IV el Día 8 y dexametasona oral 12 mg el Día 8 y 8 mg/día los Días 9,10 y 11. En el estudio el ABC de etinilestradiol disminuyó un 19% el Día 10, y hubo hasta un 64% de disminución en la concentración de etinilestradiol durante los Días 9 al 21. Mientras que no hubo efecto de aprepitant oral sobre el ABC de noretindrona en el Día 10, hubo hasta un 60% de disminución en las concentraciones de noretindrona durante los Días 9 al 21.

La eficacia de los anticonceptivos hormonales puede ser reducida durante y hasta 28 días después de la administración de fosaprepitant. Métodos alternativos o de reemplazo deben ser usados durante el tratamiento con fosaprepitant y hasta 1 mes después de la última dosis de fosaprepitant.

Midazolam: Fosaprepitant 150mg administrado en dosis única intravenosa en el Día 1, aumentó el ABC0-∞ de midazolam, aproximadamente 1.8 veces en el Día 1 y no tuvo efecto (1.0 veces) en el Día 4 cuando midazolam fue coadministrado en dosis oral única de 2mg en los Días 1 y 4. Fosaprepitant 150 mg I.V. es un inhibidor débil de la CYP3A4 en dosis individuales en el Día 1 sin evidencia de inhibición o inducción de CYP3A4 observado en el Día 4.

Efecto de otros medicamentos sobre la farmacocinética del aprepitant

El aprepitant es un sustrato de la CYP3A4, por lo tanto, la coadministración de fosaprepitant con medicamentos que inhiben la actividad de la CYP3A4 puede aumentar las concentraciones plasmáticas de aprepitant. En consecuencia, se debe tener precaución al coadministrar fosaprepitant con inhibidores potentes de la CYP3A4 (por ejemplo, ketoconazol), pero la coadministración de aprepitant con inhibidores moderados de la CYP3A4 (como el diltiazem) no causa cambios de importancia clínica en las concentraciones plasmáticas de aprepitant.

Por ser el aprepitant un sustrato de la CYP3A4, la coadministración de fosaprepitant con medicamentos que sean inductores potentes de la actividad de la CYP3A4 (como la rifampicina) puede disminuir las concentraciones plasmáticas disminuir la su eficacia.

Ketoconazol: Cuando se administró una sola dosis de 125 mg de aprepitant oral en el Día 5 de un régimen de diez días de 400 mg diarios de ketoconazol, un inhibidor potente de la CYP3A4, el ABC de aprepitant aumentó aproximadamente 5 veces y su promedio de vida media terminal de aprepitant aumentó aproximadamente tres veces. Se debe tener precaución al coadministrar fosaprepitant con inhibidores potentes de la CYP3A4.

Rifampicina: Cuando se administró una dosis única de 375 mg de aprepitant oral el Día 9 de un régimen de 14 días con 600 mg diarios de rifampicina, un inductor potente de la CYP3A4, el ABC de aprepitant disminuyó aproximadamente 11 veces y su promedio de vida media terminal disminuyó aproximadamente 3 veces. La coadministración de fosaprepitant con medicamentos que inducen la actividad de la CYP3A4 puede disminuir la concentración plasmática y la eficacia.

La administración concomitante de fosaprepitant con sustancias activas que inhiban la actividad del CYP3A4 (por ej., ketoconazol, itraconazol, voriconazol, posaconazol, claritromicina, telitromicina, nefazodona, e inhibidores de proteasa) se debe abordar cuidadosamente, dado que es de esperar que la combinación produzca concentraciones plasmáticas de aprepitant aumentadas varias veces. Ketoconazol aumentó alrededor de 3 veces la vida media terminal de aprepitant oral.

Se debe evitar la administración concomitante de fosaprepitant con sustancias activas que induzcan potentemente la actividad del CYP3A4 (por ej., rifampicina, fenitoína, carbamazepina, fenobarbital) puesto que la combinación podría producir reducciones de las concentraciones plasmáticas de aprepitant, que pueden dar como resultado disminución de la eficacia. No se recomienda la administración concomitante de fosaprepitant con preparaciones herbales que contengan St. John's Wort (*Hypericum perforatum*). Rifampicina redujo un 68 % la vida media terminal promedio de aprepitant oral.

Interacciones adicionales

Diltiazem: En pacientes con hipertensión leve a moderada, la infusión de 100mg de fosaprepitant durante 15 minutos con 120mg de diltiazem 3 veces al día, conllevó a un aumento del ABC del aprepitant 1.5 veces y del diltiazem en 1.4 veces. Entre los efectos farmacocinéticos se encuentra una pequeña disminución en la presión sanguínea diastólica con importancia clínica (disminución de 16.8mm Hg con fosaprepitant Vs. 10.5 mm Hg sin fosaprepitant). Igualmente, puede presentarse una pequeña disminución en la presión sanguínea sistólica con significancia clínica (disminución de 24.4 mm Hg con fosaprepitant Vs. 18.8 mm Hg sin fosaprepitant), pero no se presentó un cambio clínicamente significativo en la frecuencia cardíaca o en el intervalo PR, más allá de los efectos inducidos por diltiazem solo.

Paroxetina: La coadministración una vez al día de aprepitant en una tableta equivalente a la cápsula de 85 mg ó 170 mg con 20 mg de paroxetina una vez al día disminuyó aproximadamente 25% las ABCs y aproximadamente 20% las Cmáx de ambos medicamentos.

Fertilidad, embarazo y lactancia

Anticoncepción en hombres y mujeres

La eficacia de los anticonceptivos hormonales se puede disminuir durante y por 28 días después de la administración de fosaprepitant. Se deben usar métodos anticonceptivos no hormonales de respaldo durante el tratamiento con fosaprepitant y por 2 meses después de la última dosis de fosaprepitant.

Embarazo

No se dispone de datos clínicos sobre fosaprepitant y aprepitant en exposiciones durante el embarazo. No se ha determinado por completo el potencial de toxicidades reproductivas de fosaprepitant y aprepitant, dado que en estudios realizados en animales no se pudieron obtener los niveles de exposición por encima de la exposición terapéutica en humanos. Estos estudios no indicaron efectos perjudiciales directos o indirectos con respecto al embarazo, desarrollo embrionario/fetal, parto, o desarrollo postnatal. Se desconocen los efectos potenciales en la reproducción de alteraciones en la regulación de neuroquinina. Fosaprepitant no se debe usar durante el embarazo a menos que sea claramente necesario.

Lactancia materna

Aprepitant se excreta en la leche de ratas lactantes después de la administración intravenosa de fosaprepitant, como también después de administración oral de aprepitant**.** Se desconoce si aprepitant se excreta en la leche humana. Por consiguiente, no se recomienda la lactancia materna durante el tratamiento con fosaprepitant.

Fertilidad

No se ha determinado por completo el potencial de efectos de fosaprepitant y aprepitant sobre la fertilidad debido a que en estudios realizados en animales no se pudieron obtener los niveles de exposición por encima de la exposición terapéutica en humanos. Estos estudios no indicaron efectos perjudiciales directos o indirectos con respecto al desempeño del apareo, fertilidad, desarrollo embrionario/fetal, o conteo y motilidad de espermatozoides.

Efectos sobre la habilidad para conducir vehículo y operar maquinaria

Fosaprepitant puede tener influencia menor sobre la habilidad para conducir vehículo y operar maquinaria. Puede ocurrir mareo y fatiga después de la administración de fosaprepitant.

Efectos indeseables

Debido a que el fosaprepitant es convertido a aprepitant, todos los eventos adversos asociados con aprepitant pueden también ocurrir con Fosaprepitant IV.
La seguridad global de fosaprepitant fue evaluada en aproximadamente 1100 individuos., mientras que la seguridad global de aprepitant fue evaluada aproximadamente en 6500 individuos.

Prevención de las náuseasuesas y el vómito inducidos por qumioterapia

Quimioterapia moderamente emetogénica

En un estudio clínico activo – controlado en pacientes recibiendo quimioterapia moderadamente emetogénica, la seguridad fue evaluada en 504 pacientes recibiendo una dosis única de FOSAPREPITANT IV en combinación con ondansetron y dexametasona (régimen fosaprepitant) comparado con 497 pacientes recibiendo ondansetron y dexametasona solas (régimen control). Las siguientes experiencias adversas relacionadas con el medicamento clínicamente importantes fueron reportadas en pacientes tratados con el régimen de fosaprepitant a una mayor incidencia que en el grupo control.

[Comunes (≥1/100, <1/10); Poco comunes (≥1/1000, <1/100)]

Trastornos cardiacos:
Poco comunes: Palpitaciones

Trastornos gastrointestinales
Comunes: Estreñimiento
Poco comunes: Distención abdominal, dolor abdominal, dolor abdominal superior, dispepsia

Trastornos generales y alteraciones en el sitio de administración:
Comunes: Dolor en el sitio de infusión
Poco comunes: Astenia

Infecciones e Infestaciones:
Poco comunes: Candidiasis oral

Trastornos metabólicos y nutricionales:
Poco comunes: Disminución del apetito

Trastornos respiratorios, torácicos y mediastinales:
Poco comunes: Tos, dolor orofaringeo, irritación de la garganta

Trastornos vasculares
Poco comunes; Sofocos

Quimioterapia altamente emetogénica

En un estudio clínico activo - controlado con pacientes recibiendo quimioterapia altamente emetogénica, la seguridad fue evaluada en 1143 pacientes recibiendo una dosis única de FOSAPREPITANT IV 150mg comparado con 1169 pacientes que recibieron el régimen de 3 días con FOSAPREPITANT (aprepitant). El perfil de seguridad fue generalmente similar al observado en el estudio de quimioterapia moderadamente emetogénica con fosaprepitant.

Las siguientes experiencias adversas adicionales clínicamente importantes relacionados con el medicamento ocurrieron con fosaprepitant 150mg y no han sido reportados en estudios clínicos previos con aprepitant oral ó en el estudio de quimioterapia moderadamente emetogénica con fosaprepitant

[Comunes (≥1/100, <1/10) Poco comunes (≥1/1000, <1/100), Raros (≥1/10.000, <1/1000)]
Trastornos generales y en el sitio de la administración:
Poco comunes: Eritema en el sitio de infusión, prurito en el sitio de infusión.
Raros: endurecimiento en el sitio de infusión

Investigaciones:

Poco comunes: Incremento de la presión sanguínea

Trastornos de la piel y tejido subcutáneo:
Poco comunes: Eritema

Desordenes vasculares:
Poco comunes: enrojecimiento, tromboflebitis (predominantemente tromboflebitis del sitio de infusión).

Debido a que el fosaprepitant es convertido a aprepitant, todos los eventos adversos asociados con aprepitant pueden también ocurrir con Fosaprepitant IV.

Experiencia post- comercialización:
Los siguientes eventos adversos han sido identificados durante el uso en la etapa de post-comercialización. Debido a que estos eventos se reportan voluntariamente por medio de una población de tamaño incierto, generalmente no es posible establecer con seguridad su frecuencia o determinar las relaciones causales con el medicamento.

Trastornos de la piel y tejido subcutáneo: prurito, erupción, urticaria, raramente síndrome de Stevens-Johnson/necrólisis epidérmica tóxica.

Trastornos del sistema inmune: Reacciones de hipersensibilidad incluyendo reacciones anafilácticas/shock anafiláctico.

Reacciones de hipersensibilidad inmediata se han observado durante la infusión de fosaprepitant, lo cual puede incluir: enrojecimiento, eritema, disnea.

Otros eventos adversos reportados con aprepitant oral y fosaprepitant incluyen hipo, aumento de la alanino aminotransferasa (ALT), cefalea, fatiga, infección por estafilococo, neutropenia febril, anemia, polidipsia, ansiedad, desorientación, estado anímico eufórico, mareo, somnolencia, trastorno cognitivo, letargia, disgeusia, conjuntivitis, tínnitus, bradicardia, trastorno cardiovascular, estornudos, goteo postnasal, eructos, náuseas, vómito, reflujo gastroesofágico, boca seca, flatulencia, perforación de úlcera duodenal, estomatitis, distensión abdominal, heces duras, colitis neutropénica, acné, reacción de fotosensibilidad, hiperhidrosis, seborrea, lesiones cutáneas, debilidad muscular, espasmos musculares, disuria, polaquiuria, malestar, edema, malestar torácico, alteración de la marcha, aumento de la AST, aumento de la fosfatasa alcalina, eritrocitos en orina, disminución del sodio sérico, pérdida de peso, disminución del recuento de neutrófilos, presencia de glucosa en la orina, reducción de la producción de orina, dolor abdominal alto, ruidos intestinales anormales, disartria, disnea, hipoestesia, insomnio, miosis, alteración sensorial, malestar estomacal, sub-íleo, reducción de la agudeza visual, sibilancias, rubefacción, dolor en el sitio de infusión, e induración del sitio de infusión.

Sobredosis

En caso de sobredosis, se debe suspender la administración de fosaprepitant y proveer tratamiento de cuidado de apoyo general y monitoreo. Debido a la actividad antiemética de aprepitant, es posible que no sea efectiva la emesis inducida por un producto medicinal.

Aprepitant no puede ser eliminado por hemodiálisis.

INFORMACIÓN FARMACOLÓGICA

Propiedades farmacodinámicas

Fosaprepitant es la prodroga de aprepitant y al administrarse vía intravenosa se convierte rápidamente en aprepitant. No se ha determinado por completo la contribución de fosaprepitant al efecto antiemético global, pero no se puede descartar una contribución transitoria durante la fase inicial. Aprepitant es un antagonista selectivo de alta afinidad por los receptores de la sustancia P neuroquinina 1 (NK1) humana. El efecto farmacológico de fosaprepitant se atribuye a aprepitant.

Propiedades farmacocinéticas

Fosaprepitant, una prodroga de aprepitant, se convierte rápidamente en aprepitant cuando se administra vía intravenosa. Las concentraciones plasmáticas de fosaprepitant son inferiores a los niveles cuantificables dentro de 30 minutos después de completarse la infusión.

<u>Aprepitant después de la administración de fosaprepitant</u>

Después de una dosis intravenosa única de 150 mg de fosaprepitant administrada como infusión durante 20 minutos a adultos sanos voluntarios, el $AUC_{0-\infty}$ medio de aprepitant fue de 35.0 µg•hr/ml y la concentración máxima media de aprepitant fue de 4.01 µg/ml.

<u>Distribución</u>

Aprepitant se une fuertemente a proteínas, con un promedio de 97%. La media geométrica del volumen de distribución en estado estable (Vd_{ss}) de aprepitant, estimado a partir de una sola dosis intravenosa de 150 mg de fosaprepitant es de aproximadamente 82 l en humanos.

Biotransformación

Fosaprepitant se convirtió rápidamente a aprepitant en incubaciones *in vitro* con preparaciones hepáticas humanas. Adicionalmente, fosaprepitant experimentó conversión rápida y casi completa a aprepitant en preparaciones S9 de otros tejidos humanos, incluyendo riñones, pulmones e íleon. De este modo, parece que la conversión de fosaprepitant a aprepitant puede ocurrir en múltiples tejidos. En humanos, fosaprepitant administrado vía intravenosa se convirtió rápidamente a aprepitant dentro de 30 minutos después de finalizar la infusión.

Aprepitant experimenta metabolismo extenso. En adultos jóvenes sanos, aprepitant es responsable de aproximadamente el 19% de la radioactividad en plasma durante 72 horas después de la administración intravenosa única de una dosis de 100 mg de [^{14}C]-fosaprepitant, una prodroga de aprepitant, indicando una presencia sustancial de metabolitos en el plasma. Se han identificado doce metabolitos de aprepitant en el plasma humano. El metabolismo de aprepitant ocurre en gran medida a través de oxidación en el anillo morfolina y sus cadenas laterales, y los metabolitos resultantes solo fueron débilmente activos. Estudios *in vitro* usando microsomas hepáticos humanos indican que aprepitant es metabolizado principalmente por el CYP3A4 y potencialmente, con una contribución menor, por el CYP1A2 y el CYP2C19.

También se observaron todos los metabolitos en la orina, heces y plasma después de una dosis intravenosa de 100 mg de [^{14}C]-fosaprepitant después de una dosis oral de [^{14}C]-aprepitant. Al convertir 245.3 mg de fosaprepitant dimeglumina (equivalente a 150 mg de fosaprepitant) a aprepitant, se liberan 23.9 mg de ácido fosfórico y 95.3 mg de meglumina.

Eliminación

Aprepitant no se excreta sin modificación en la orina. Los metabolitos se excretan en la orina y a través de excreción biliar en las heces. Después de una sola dosis vía intravenosa de 100 mg de [^{14}C]-fosaprepitant administrada a sujetos sanos, se recuperó el 57% de la radioactividad en la orina y el 45 % en las heces.

La farmacocinética de aprepitant es no lineal a través del rango clínico de dosificación. La vida media terminal de aprepitant después de una dosis intravenosa de 150 mg de fosaprepitant fue de aproximadamente 11 horas. La media geométrica de la eliminación plasmática de aprepitant después de una dosis intravenosa de 150 mg de fosaprepitant fue de aproximadamente 73 ml/min.

Farmacocinética en poblaciones especiales

Daño hepático:

Fosaprepitant es metabolizado en varios tejidos extrahepáticos; por lo tanto, no es de esperar que el daño hepático altere la conversión de fosaprepitant a aprepitant. El daño hepático leve (clase A Child-Pugh) no afecta la farmacocinética de aprepitant hasta una magnitud clínicamente relevante. No se requiere ajuste de la dosis para pacientes con daño hepático leve. A partir de los datos disponibles, no es posible extraer conclusiones referentes a la influencia del daño hepático moderado (clase B Child-Pugh) sobre la farmacocinética de aprepitant. No existen datos clínicos o farmacocinéticos en pacientes con daño hepático severo (clase C Child-Pugh).

Daño renal:

Se administró una sola dosis oral de 240 mg de aprepitant a pacientes con daño renal severo (CrCl< 30 ml/min) y a pacientes con enfermedad renal terminal (ESRD) que requerían hemodiálisis.

En pacientes con daño renal severo, el $AUC_{0-\infty}$ del total de aprepitant (no ligado y ligado a proteína) se redujo un 21% y la $C_{máx}$ disminuyó un 32%, en relación con sujetos sanos. En pacientes con ESRD sometidos a hemodiálisis, el $AUC_{0-\infty}$ del total de aprepitant disminuyó un 42% y la $C_{máx}$ se redujo un 32%. Debido a reducciones moderadas en la unión a proteína de aprepitant en pacientes con enfermedad renal, el AUC de aprepitant farmacológicamente activo no unido a proteína no se vio afectado significativamente en pacientes con daño renal comparados con sujetos sanos. La hemodiálisis realizada 4 o 48 horas después de la dosificación no tuvo efecto significativo en la farmacocinética de aprepitant; en el dializado se recuperó menos del 0.2% de la dosis.

No se requiere ajuste de la dosis para pacientes con daño renal o para pacientes con ESRD sometidos a hemodiálisis.

Población pediátrica:

Después de la administración de una sola dosis IV de 150 mg de fosaprepitant a pacientes adolescentes (con edad de 12 a 17 años), la $C_{máx}$ media de aprepitant y el $AUC_{0-\infty}$ fueron de aproximadamente 5.9 µg/mL y 43.6 µg•hr/mL, respectivamente. Después de la administración de una sola dosis IV de 3 mg/kg de fosaprepitant a pacientes pediátricos de 6 meses a <12 años de edad, la $C_{máx}$ media de aprepitant y el $AUC_{0-\infty}$ fueron de aproximadamente 2.4 µg/mL y 20.8 µg•hr/mL, respectivamente.

Relación entre la concentración y el efecto

Estudios de imágenes de tomografía por emisión de positrones (PET), usando un trazador de receptor NK_1 altamente específico, en hombres jóvenes sanos a quienes se administró una sola dosis intravenosa de 150 mg de fosaprepitant (N=8), demostraron ocupación en el receptor NK_1 cerebral ≥100% a un $T_{máx,}$ y a las 24 horas, ≥97 % a las 48 horas, y entre 41% y 75% a las 120 horas, después de la dosificación. En este estudio, la ocupación de receptores NK_1 en el cerebro se correlaciona de manera apropiada con las concentraciones plasmáticas de aprepitant.

INFORMACIÓN FARMACÉUTICA

Almacenamiento:

Los viales de fosaprepitant para inyección se deben "almacenar en refrigerador a una temperatura de 2° C a 8 °C".

Condiciones de almacenamiento durante el uso y período de almacenamiento:

La solución final reconstituida del medicamento es estable durante 24 horas a temperatura hasta de 30 °C en solución salina 0.9%.

Presentación:

Vial de vidrio de una dosis que contiene 150 mg de fosaprepitant en forma de una masa o polvo liofilizado de color blanco a blanco marfil.

V. 02. Octubre de 2018